·文献综述·

针灸治疗卒中后失语症临床研究概况

马　斌[1],柳　刚[1],宋书婷[2],王友刚[1],杨　骏[3]

(1.安徽中医药大学第二附属医院脑病三科,安徽　合肥　230061;
2.安徽中医药大学第一附属医院治未病中心,安徽　合肥　230031;
3.安徽中医药大学第一附属医院针灸康复科,安徽　合肥　230031)

摘要:查阅相关文献,从舌针、体针、头针、眼针、灸法、放血疗法、经颅磁刺激及中医综合疗法八方面对近年来针灸治疗卒中后失语症的临床研究现状进行概述。针灸治疗卒中后失语症临床疗效肯定,但目前研究存在疾病类型不够明确、疗效评价标准不统一、临床试验样本量小、机制研究不够深入等问题。指出在今后的研究中需对不同类型的失语症选择不同的筛查和评价量表,进行针对性研究;同时需加强对针刺疗效相关影响因素的把控,并同步增加多中心、大样本且高质量的临床随机对照试验;机制研究还应从血液标记物、神经电生理变化、神经环路等方面进行深入研究。

关键词:卒中后失语症;针灸;临床研究;综述

中图分类号:R246.6　**文献标志码:**A　**文章编号:**1003-8450(2025)01-0072-06

DOI:10.16841/j.issn1003-8450.2025.01.13

卒中后失语症又称卒中后语言障碍,是指大脑中与言语相关的组织损伤造成患者对语言符号的认知、理解、表达、运用等出现障碍,是卒中后常见后遗症之一。现代医学尚无针对失语症本身的特效药,主要通过语言康复训练以及一些物理方法治疗,方法较单一,疗效较慢。而中医在治疗卒中后失语症方面做出了显著贡献,通过不断的临床与基础研究,针灸已被证实治疗卒中后失语症疗效确切,并能缩短患者的康复时间。此外,针灸还具有简便易行、成本低廉、无不良反应等优势。现将针灸治疗卒中后失语症的临床研究现状概述如下。

1　舌针为主

舌针是在中医针刺理论指导下,结合现代解剖生理及生物全息论,通过针刺舌部特定穴位治疗疾病的方法,是"腧穴近治作用"的体现。《灵枢·忧患无言》曰:"咽喉者,水谷之道也……舌者,音声之机也……横骨者,神气所使,主发舌者也。"可见舌与正常的言语功能以及异常的失语状态之间存在紧密的联系。更重要的是,舌也是治疗失语症的关键部位[1],通过针刺舌上的特定穴位可达到治疗的目的,其中金津和玉液穴为最常使用的穴位。张定戎等[2]将64例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各32例。对照组给予常规西医方法(舌体运动训练、软腭抬高训练等)治疗;治疗组在对照组治疗方法的基础上针刺舌根部的金津、玉液穴,待获得酸、麻等针感后起针,隔日针刺1次,共治疗10次。结果治疗后治疗组语言功能、口语表达评分,听说理解、阅读能力,血浆降钙素基因相关肽(CGRP)水平均明显高于对照组($P<0.05$);血浆血管内皮素(ET)水平明显低于对照组($P<0.05$)。说明其机制可能是通过针刺金律、玉液穴调节血浆ET和CGRP水平,从而缓解大脑缺血缺氧状态,减轻失语症状。侯利红等[3]将120例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和观察组,各60例。对照组给予语言康复训练,隔日1次,共治疗15次。观察组在对照组治疗方法的基础上给予针刺治疗,取穴舌三针、百会及哑门,舌三针向舌根方向斜刺15~25 mm,施以提插捻转强刺激;百会和哑门直刺15~33 mm,施以轻捻转补法,每日针刺1次,10 d为1个疗程,1个疗程后休息10 d,共治疗2个疗程。结果治疗后观察组最长发音时间明显长于对照组($P<0.05$),词语和语句正确率及说、理解、读、写评分均明显高于对照组($P<0.05$)。

2　体针为主

体针治疗失语症通常依据"经络所过,主治所及"及"辨证论治"理论,是"腧穴远治作用"的体现。

基金项目:国家973计划项目(2010CB530505);安徽中医药大学自然科学项目(2020efyzc11)。

作者简介:马斌(1992-),男,主治医师,医学硕士。研究方向:针灸临床应用及其机制研究。

通信作者:柳刚(1976-),男,主任医师,博士生导师,医学博士。研究方向:针刺临床及机制研究。E-mail:442738117@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

《黄帝内经》记载:“手少阴之别……循经入于心中,系舌本。”“脾足太阴之脉……连舌本,散舌下。”“肾足少阴之脉……循喉咙,挟舌本。”“肝者……脉络于舌本也。”“足太阳之筋……其支者,别入结于舌本。”“手少阳之筋……其支者,当曲颊入系舌本。”由此可见,心、脾、肾、肝、膀胱、三焦等脏腑经络均与舌相关联,故亦可取相关脏腑经络上的穴位治疗失语症。王儒蒙等[4]将60例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和治疗组,各30例。对照组给予常规针刺,取穴廉泉、风池、完骨、照海、合谷、太冲;治疗组选取心经络穴通里穴加常规穴位(同对照组)针刺。2组均每周治疗6 d,休息1 d,2周为1个疗程,连续治疗2个疗程。结果治疗后治疗组自发谈话、复述、命名能力评分均明显高于对照组($P<0.05$),总有效率(93.33%)明显高于对照组(73.33%)。刘伟新等[5]将90例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各45例。2组均给予拜阿司匹林肠溶片(每日1次,每次100 mg)口服,在此基础上,对照组给予普通针刺(主穴取哑门、舌三针、双侧通里)治疗;治疗组给予培土生金针刺法治疗,取穴脾经太白、肾经太溪、肺经太渊,采用1.5寸毫针直刺0.3~0.5寸,行捻转提插1 min后留针。2组均每日针刺1次,10 d为1个疗程,疗程间休息2 d。治疗3个疗程后,治疗组总有效率(82.2%)明显高于对照组(40.0%)($P<0.01$)。翟军萍[6]将69例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和观察组,对照组34例给予语言康复训练;观察组35例在对照组治疗方法的基础上给予针灸益脑调神法治疗,取穴百会、肾俞、心俞,百会穴平刺,肾俞穴直刺,心俞穴斜刺,均行提插捻转补法,留针30 min。结果治疗后观察组2级率明显低于对照组,3级率及4级率均明显高于对照组($P<0.05$)。刘兢等[7]将74例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,对照组38例给予语言康复训练;治疗组36例在对照组治疗方法的基础上取肝经太冲、三焦经关冲、心包经中冲、心经兑冲(神门),施以阴中隐阳手法。2组均每日治疗1次,1周为1个疗程。结果治疗4周后治疗组总有效率(81.58%)明显高于对照组(72.22%)($P<0.05$),口语表达、阅读能力、听语理解评分均明显高于对照组($P<0.05$)。

3 头针为主

“头为诸阳之会”“诸经皆归于脑”,脑为元神之府,舌窍机关皆为神所主。因此,头针可直通病所,发挥调神醒脑的功效[8]。依据大脑皮层的功能定位和经络学说原理,头针比较常用的穴位有“焦氏头针”中的言语Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区。李亚东[9]将78例缺血性卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各39例。对照组给予语言康复训练;治疗组在对照组治疗方法的基础上以梅花针轻扣顶颞后斜线、顶中线、顶颞前斜线、曲鬓穴及悬厘穴连线的四线围定区域。2组均以7 d为1个疗程,共治疗4个疗程。结果治疗后治疗组总有效率(87.2%)明显高于对照组(66.7%)($P<0.05$),命名、复述、流利性、信息量评分均明显高于对照组($P<0.05$)。张若萌等[10]将76例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和治疗组,各38例。对照组给予语言康复训练;治疗组在对照组治疗方法的基础上以醒脑开窍、化瘀通络为治则,给予头皮针针刺,取言语Ⅰ区、Ⅲ区斜向进针,快速捻转至得气。2组均每日治疗1次,每周治疗6 d,共治疗8周。结果治疗后治疗组总有效率(94.7%)明显高于对照组(89.4%)($P<0.05$),中国康复研究中心汉语标准失语检查表(CRRCAE)中的各项言语功能评分均明显高于对照组($P<0.05$)。杨玲等[11]将90例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各45例。对照组给予语言康复训练;治疗组在对照组治疗方法的基础上电针头部穴位,根据失语症的类型,运动性失语症取运动区,感觉性失语症取感觉区,完全性失语症取言语Ⅲ区。2组均每周治疗5次,2周为1个疗程,共治疗1个疗程。结果治疗组自发说话、理解、复述、命名评分均明显高于对照组($P<0.05$)。楼喜强等[12]将54例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和观察组,各27例。2组均给予西医基础治疗及语言康复训练,在此基础上对照组于患侧顶颞前斜线下2/5、颞前线予常规头针治疗;观察组于双侧顶颞前斜线下2/5、颞前线予头针治疗,得气后脑梗侧予疏密波(兴奋)电刺激,非脑梗侧予连续波(抑制)电刺激。2组均每日治疗1次,5次为1个疗程,共治疗2个疗程。结果治疗后观察组总有效率(92.3%)明显高于对照组(84.0%),复述、听理解、命名、自发谈话评分均明显高于对照组($P<0.05$),波士顿失语症严重程度(BDAE)分级明显优于对照组($P<0.05$)。

4 眼针为主

“五脏六腑之精气,皆上注于目而为睛”“十二经脉三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍,其经阳气上走于目而为之睛”。眼和脏腑及经络的紧密联系是眼针能够治疗全身疾病的重要生理基础。张

中国知网 https://www.cnki.net

小罗等[13]将60例卒中后失语症患者随机分为A、B、C 3组,各20例。A组予以眼针配合语言康复训练,眼针取穴心区、肝区、肾区、脾区、上焦区、下焦区,采用毫针沿皮刺入,得气后不施手法,留针30 min;语言康复训练采用Schuell刺激法训练。2种方法均每日1次,7次为1个疗程,共治疗3个疗程,疗程间休息1 d。B组予以单纯眼针针刺,方法及疗程同A组。C组予以语言康复训练,方法及疗程同A组。结果治疗后A组自发语言、口语理解、命名语言功能评分,失语商(AQ)评分,日常生活语言沟通能力(CFCP)评分均明显升高,与C组比较差异均有统计学意义($P<0.05$);A组总有效率(95.0%)均明显高于B组(80.0%)和C组(85.0%),差异有统计学意义($P<0.05$)。张雯舒等[14]将120例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各60例。2组均给予西医常规疗法,在此基础上,对照组给予语言康复训练;治疗组在对照组治疗方法的基础上给予眼针针刺,取穴上焦区、肝区、肾区、下焦区,留针期间行运动疗法,2组均治疗8周。结果治疗后治疗组总有效率(95.0%)明显高于对照组(82.0%),理解、复述、说、朗读、阅读五项功能评分均明显高于对照组($P<0.05$)。

5 灸法为主

何桥景等[15]将86例卒中后失语症气血亏虚证患者随机分为对照组和治疗组,各43例。2组均选取语言区、百会、四神聪、太阳、风池穴,对照组给予常规针刺,治疗组在对照组治疗方法的基础上麦粒灸通里穴。2组均以10 d为1个疗程,共治疗2个疗程。结果治疗后治疗组总有效率(86.05%)明显高于对照组(58.14%)($P<0.01$)。柳刚等[16]将60例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各30例。对照组给予语言康复训练;治疗组在对照组治疗方法的基础上重灸百会穴,每周艾灸6次,每次1 h,共治疗4周。结果治疗后治疗组总有效率(90.0%)明显高于对照组(66.7%)($P<0.01$),书写、复述、命名评分均明显高于对照组($P<0.05$)。欧阳彩霞等[17]将60例卒中后失语症患者随机分为对照组和观察组,各30例。对照组给予语言康复训练,观察组在对照组治疗方法的基础上给予神阙隔物灸,2组均每周治疗5次,共治疗4周。结果治疗后观察组朗读、复述、表达评分均明显高于对照组($P<0.05$)。费爱华等[18]将55例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,对照组27例给予头针及舌面点刺,每日1次,每周6次,间隔1 d后继续治疗;治疗组28例在对照组治疗方法的基础上结合调任复元灸法,在中脘、关元、双侧胃经之间的区域进行艾灸,每周1次。治疗4周后,治疗组理解、命名、复述能力均明显高于对照组($P<0.05$)。

6 放血疗法为主

程秀宇等[19]将80例卒中后失语症患者随机分为康复组和综合组,各40例。康复组给予语言康复训练;综合组在康复组治疗方法的基础上取金津、玉液穴点刺放血,每隔2 d放血1次,并结合言语功能区针刺,每日1次。治疗4周后,综合组BDAE级别明显优于康复组($P<0.05$),阅读、理解、复述及交流评分均明显高于康复组($P<0.01$)。刘振华等[20]将100例卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各50例。对照组予以重复经颅磁刺激;治疗组在对照组治疗方法的基础上取双侧太冲、关冲、中冲、神门穴点刺放血,2组均连续治疗2周。结果治疗后治疗组总有效率(94.0%)明显高于对照组(82.0%)($P<0.05$),复述、书写、理解、阅读能力评分均明显高于对照组($P<0.05$),焦虑自评量表(SAS)及抑郁自评量表(SDS)评分均明显低于对照组($P<0.05$)。

7 经颅磁刺激为主

乔玉等[21]将44例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和治疗组,各22例。对照组针刺百会、言语Ⅰ区、廉泉、通里、金津、玉液,其中言语Ⅰ区、百会接电针,使用疏密波;治疗组在对照组治疗方法的基础上给予右侧半球Broca对应区低频重复经颅磁刺激。治疗4周后治疗组总有效率(80.00%)明显高于对照组(68.18%)($P<0.05$),自发谈话、复述、理解、命名评分及日常生活活动能力(ADL)评分均明显高于对照组($P<0.05$),汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分明显低于对照组($P<0.05$)。彭拥军等[22]将66例卒中后失语症患者随机分为对照组、高频组及低频组,各22例。对照组给予电针结合语言康复训练,在对照组治疗方法的基础上,高频组予以左侧Broca区高频刺激,低频组予右侧Broca对应区低频刺激。3组均每日治疗1次,每周5次,共治疗20次。结果治疗后高频组、低频组总有效率(均为80.00%)均明显高于对照组(63.63%)($P<0.05$),ADL评分均明显高于对照组($P<0.05$),HAMD评分均明显低于对照组($P<0.05$)。

8 中医综合疗法

熊杰等[23]将64例卒中后失语症患者随机分为对照组和联合组,各32例。对照组给予西医基础治

中国知网 https://www.cnki.net

疗结合语言康复训练;联合组在对照组治疗方法的基础上给予醒脑开窍针刺法治疗,主穴取人中、内关(双侧)、三阴交(患侧),辅穴取极泉(患侧)、尺泽(患侧)、委中(患侧),再加以金津、玉液点刺放血。每日针刺1次,留针30 min,每周治疗5次,休息2 d,连续治疗5周。结果治疗后联合组口语理解、自发言语、命名及复述等语言功能评分,AQ、CFCP评分均明显高于对照组($P<0.05$),美国国立院神经功能缺损(NIHSS)评分明显低于对照组($P<0.05$),运动性失语程度明显轻于对照组($P<0.01$),联合组总有效率(71.88%)明显高于对照组(37.50%)($P<0.05$)。王琨等[24]将65例卒中后运动性失语症患者随机分为对照组和治疗组,2组均给予"调神通络"针法(头针穴取顶中线、顶斜1线、顶旁线、顶斜2线,体针穴取风池、外关、曲池、臂臑、涌泉、足三里、四强)治疗,在此基础上对照组32例予舌三针治疗,穴取上廉泉、廉泉左(双侧),行平补平泻捻转提插手法,留针30 min,每10 min行针1次,每日1次。治疗组33例予舌五针联合咽后壁放血治疗,舌五针穴取上廉泉、廉泉左(双侧)、金津下、玉液下,留针30 min;以芒针行咽后壁刺络放血,少量出血为宜,隔日1次。2组均治疗4周,结果治疗组总有效率(93.94%)明显高于对照组(75.00%)($P<0.05$);流利性、复述能力、阅读能力、书写能力评分及总评分均明显高于对照组($P<0.05$或$P<0.01$)。刘金辉等[25]将86例卒中后失语症患者随机分为对照组和观察组,各43例。对照组给予常规西医治疗联合语言康复训练。观察组给予针刺联合中药口服治疗,头、舌、体针并用(前神聪透悬厘,百会透曲鬓,聚泉、金津、玉液点刺,通里、太溪、风池、足三里、曲池、合谷、血海直刺),每次留针30 min;中药方药组成:熟地黄30 g、生黄芪25 g、山药10 g、山茱萸15 g、郁金10 g、石菖蒲15 g、白蒺藜10 g、远志15 g、泽泻10 g、茯苓10 g、胆南星10 g、牛膝30 g。随症加减,每日1剂,早、晚2次温服。2组均连续治疗4周。结果治疗后观察组总有效率(92.02%)明显高于对照组(83.72%)($P<0.05$),复述、口语表达、听说理解、阅读、说、出声读评分及失语成套测验法评分均明显高于对照组($P<0.05$)。卢英等[26]将104例卒中后失语症患者随机分为对照组和观察组,各52例。对照组给予语言康复训练,观察组在对照组治疗方法的基础上给予针刺联合中药口服治疗。针刺选取哑门、风府、百会、顶颞前斜线下2/5处及廉泉、率谷,留针30 min;中药给予活血开窍通络方口服,方药组成:丹参15 g、赤芍15 g、川芎15 g、白术12 g、白茯苓12 g、地龙15 g、石菖蒲15 g、天麻10 g、法半夏10 g、甘草6 g。治疗4周后,观察组总有效率(88.46%)明显高于对照组(69.23%),NIHSS评分,全血高切黏度、全血低切黏度、血液黏度、红细胞压积均明显低于对照组($P<0.05$),书写、复述、阅读、听理解能力评分均明显高于对照组($P<0.05$)。贺兴辉等[27]采用头皮针针刺、舌针点刺放血结合解语膏穴位贴敷治疗卒中后失语症患者28例,头皮针取穴言语一区、言语二区、言语三区,针刺得气后留针1 h;舌针点刺放血采用毫针在舌面中后和左中右等9区进行点刺;以解语膏(药物组成:生草乌、穿山甲、三七粉、红海蛤、冰片、薄荷脑)贴敷于劳宫、涌泉穴。均每日治疗1次,6次为1个疗程,疗程间休息1 d。结果治疗4个疗程后总有效率为85.7%,命名、复述、理解、自发谈话评分及总分均明显高于治疗前($P<0.01$)。费爱华等[28]将86例卒中后运动性失语症患者随机分为针刺组、穴位贴敷组及穴位贴敷结合针刺组,针刺组28例予以针刺治疗,取穴言语一区、舌三针,行平补平泻手法,每日1次,每周针刺6 d,休息1 d,共针刺4周;穴位贴敷组29例予解语膏(药物组成:穿山甲、生乌头、红海蛤、三七粉)贴敷劳宫和涌泉穴,每日1次,双侧穴位交替进行,共治疗4周;穴位贴敷结合针刺组29例予针刺联合穴位贴敷,针刺及穴位贴敷方法同其他2组。结果针刺组、穴位贴敷组及穴位贴敷结合针刺组总有效率分别为67.9%,69.0%,86.2%,穴位贴敷结合针刺组均明显高于其他2组($P<0.05$);穴位贴敷结合针刺组自发谈话、复述、命名评分均明显高于针刺组、穴位贴敷组($P<0.05$)。李丽等[29]将60例缺血性卒中后失语症患者随机分为对照组和治疗组,各30例。对照组给予普通针刺治疗,穴取水沟、百会、极泉、尺泽、委中、三阴交、足三里、通里、廉泉三针;治疗组予管氏舌针(穴取心穴、肝穴、脾穴、肾穴、聚泉、金津、玉液、中矩)联合颅底七穴(双风池、双完骨、双天柱、哑门)针刺,点刺金津、玉液、中矩穴,以出血为度,每周2次,其他穴位进针约1~3 mm,均匀捻10次后取出,每周针刺5 d,休息2 d。治疗4周后治疗组谈话、阅读、命名、复述评分均明显高于对照组($P<0.05$),总有效率(86.67%)明显高于对照组(73.33%)($P<0.05$)。

9 结语

失语症是脑卒中常见的并发症状之一,是阻碍脑卒中患者康复的重要因素之一,也是针灸疗法的

中国知网 https://www.cnki.net

优势病种之一。针灸治疗卒中后失语症疗效肯定、手法丰富、各具特色,包括舌针、体针、头针、眼针、灸法、放血疗法以及综合治疗等,其中头针、舌针、眼针等微针疗法在卒中后失语症治疗中的地位更是举足轻重,对其研究和报道也较多。但目前针灸治疗卒中后失语症仍存在一些问题:1)卒中后失语症有很多类型,但大部分研究并未对其进行区分,不利于对卒中后失语症的精准治疗提供更好的方案和研究支撑;2)失语症相关检查量表复杂多样,缺乏统一的疗效标准,部分临床研究的结果缺乏可靠性;3)针刺治疗时穴位、手法、刺激量大小的选择,以及留针时间的长短没有统一的标准,各种针刺参数的最佳搭配组合方式亦没有统一的标准,一定程度上阻碍了针刺疗法的推广;4)研究的样本量不够大,缺乏说服力;5)语言是人类所特有,失语症无法在动物身上造模,研究起来有所局限,目前对针刺治疗失语症的作用机制研究较少,仅在血液流变学及神经影像学等方面进行了研究,但仍不够深入。

针对以上问题,今后的研究可在吸取前人经验的同时,对不同类型卒中后失语症进行针对性研究;各种评价量表各具特色,针对不同类型的失语症应选择不同筛查和评价量表,使研究结果更有说服力;加强针刺疗效相关影响因素的把控,强化针刺手法量学在卒中后失语症中的应用研究;增加多中心、大样本且高质量的临床随机对照试验,以提高研究质量;机制研究还应从血液标记物、神经电生理变化、神经环路等方面进行,以期从不同角度更加深入地阐释针灸治疗卒中后失语症的作用机制。

参考文献:

[1]马斌,柳刚,杨骏,等. 从“舌”论针灸治疗中风失语症[J].中医药信息,2021,38(4):59-62.
[2]张定戎,陈军.针刺金津玉液对中风失语患者言语功能恢复的作用[J].中国地方病防治杂志,2016,31(10):1188-1189.
[3]侯利红,马玉翠.针灸联合康复干预对运动性构音障碍患者疗效及预后的影响研究[J].针灸临床杂志,2018,34(6):23-26.
[4]王儒蒙,焦杨.针刺通里穴治疗运动性失语的临床疗效观察[J].实用中西医结合临床,2018,18(1):135-136.
[5]刘伟新,伍艺灵.培土生金针刺法联合西药治疗中风失语症45例[J].中医研究,2019,32(9):56-58.
[6]翟军萍.针灸益脑调神法治疗中风运动性失语疗效观察[J].中医临床研究,2016,8(16):36-37.
[7]刘兢,宋敬华,李秀霞,等. “四冲穴”阴中隐阳法配合Schuell语言训练治疗缺血性脑卒中后失语[J].中西医结合心脑血管病杂志,2016,14(1):72-74.
[8]陈柱,单春雷.头针在失语症中的应用[J].实用老年医学,2020,34(2):186-189.
[9]李亚东.头针与梅花针叩刺结合语言康复训练治疗缺血性中风失语疗效观察[J].山西中医,2017,33(4):37-38.
[10]张若萌,孙善斌.头皮针联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语[J].长春中医药大学学报,2020,36(2):339-342.
[11]杨玲,郭耀光.头电针配合言语训练治疗脑卒中后失语的临床研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(3):305-308.
[12]楼喜强,刘襄,刘春花,等.头针调衡电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2021,41(11):1211-1215.
[13]张小罗,李秀彬,王位.眼针配合语言功能训练治疗中风失语症疗效观察[J].上海针灸杂志,2016,35(9):1036-1039.
[14]张雯舒,刘小平,陈飞宇,等.眼针联合言语康复对缺血性脑卒中患者身体机能及语言障碍的疗效分析[J]. 中国药物与临床,2020,20(2):246-248.
[15]何桥景,曾科学.麦粒灸通里穴治疗中风后失语气血亏虚型43例临床观察[J].湖南中医杂志,2015,31(3):95-96.
[16]柳刚,韩为,黄学勇,等.重灸百会穴法治疗脑中风后失语症30例临床研究[J].时珍国医国药,2016,27(5):1136-1138.
[17]欧阳彩霞,欧阳群,黄嗣煜,等.神阙隔物灸法结合言语训练治疗脑卒中患者失语的疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(93):149.
[18]费爱华,蔡圣朝,代飞.调任复元灸法治疗脑卒中后感觉性失语临床研究[J].安徽中医药大学学报,2018,37(3):41-44.
[19]程秀宇,吕岩峰,张虹,等.康复结合头针、放血对老年脑卒中后言语功能障碍患者的疗效[J].中国老年学杂志,2019,39(8):1821-1823.
[20]刘振华,尹昱,张卫国,等.点刺放血联合重复经颅磁刺激治疗卒中后非流利型失语症临床观察[J].河北中医,2020,42(6):837-841.
[21]乔玉,马继红,彭拥军,等.电针结合低频重复经颅磁刺激治疗中风后运动性失语的临床研究[J].针灸临床杂志,2019,35(10):15-19.
[22]彭拥军,吕鹤群,乔玉,等.电针结合不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J].辽宁中医药大学学报,2020,22(10):1-4.
[23]熊杰,张蒙,郭文丽,等.醒脑开窍针刺法结合语言康复训练治疗脑梗死运动性失语临床研究[J].中医学报,2016,31(10):1609-1613.
[24]王琨,韩舰华.舌五针联合咽后壁放血治疗中风后运动

中国知网 https://www.cnki.net

性失语33例[J].湖南中医杂志,2021,37(6):64-66.
[25]刘金辉,易满,姜迎萍.针灸联合中药组方对中风失语患者临床疗效研究[J].世界中医药,2016,11(11):2401-2403.
[26]卢英,廖炼炼,梁辉.针药并用联合康复训练对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能及血液流变学的影响[J].湖南中医药大学学报,2019,39(9):1138-1142.
[27]贺兴辉,贺成功,蔡圣朝,等.舌针、头皮针配合解语膏贴敷治疗中风后失语28例[J].中国针灸,2018,38(12):1329-1330.
[28]费爱华,蔡圣朝,徐斌.解语膏穴位贴敷结合针刺治疗中风后运动性失语临床研究[J].中国针灸,2015,35(11):1099-1102.
[29]李丽,黄培冬,栾莎,等.管氏舌针结合颅底七穴治疗缺血性脑卒中后失语症的临床研究[J].中华中医药杂志,2020,35(11):5851-5854.

Clinical research overview of acupuncture in the treatment of post-stroke aphasia

MA Bin[1], LIU Gang[1], SONG Shuting[2], WANG Yougang[1], YANG Jun[3]
(1.Department of Neurology III, the Second Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine, Hefei, Anhui, 230061, China;
2.Center for Preventive Medicine, the First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine, Hefei, Anhui, 230031, China;
3.Department of Acupuncture and Rehabilitation, the First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine, Hefei, Anhui, 230031, China)

Abstract: This paper reviews the relevant literature to summarize the current clinical research status of acupuncture in treating post-stroke aphasia, focusing on eight main aspects: tongue acupuncture, body acupuncture, head acupuncture, eye acupuncture, moxibustion, bloodletting therapy, transcranial magnetic stimulation, and integrative Chinese medicine. The clinical efficacy of acupuncture for post-stroke aphasia is well-established; however, several issues persist in contemporary research, including ambiguous disease classifications, inconsistent evaluation criteria, small sample sizes in clinical trials, and a lack of thorough mechanistic investigations. Future studies should employ distinct screening and evaluation scales tailored to different types of aphasia for more targeted research. Additionally, it is essential to enhance the control over factors influencing the efficacy of acupuncture while simultaneously increasing multi-center, large-sample high-quality randomized controlled trials. Mechanistic research should also be further explored through avenues such as blood markers, neuroelectrophysiological changes, and neural circuitry.

Keywords: post-stroke aphasia; acupuncture; clinical research; overview

(2022-05-15收稿;2022-06-02修回)
[编辑:张志红]

中国知网 https://www.cnki.net